

La pieloplastia es una cirugía para reparar una obstrucción donde el riñón drena hacia el uréter, el tubo que lleva la orina a la vejiga. Esta unión puede ser muy estrecha, retener orina y causar dolor, infecciones o daño renal. La pieloplastia quita el segmento obstruido y reconstruye una conexión amplia que drena libremente — la reparación más duradera, con un éxito de más del 90%.

Acerca de este procedimiento

En la parte alta del uréter, donde se une a la bolsa colectora del riñón (la **pelvis renal**), un estrechamiento puede frenar el drenaje de la orina. A veces un **vaso sanguíneo** cercano lo presiona. Esto se llama **obstrucción de la unión ureteropélvica (UPU)**. En la pieloplastia, su cirujano:

- Quita el segmento estrecho
- Une el uréter sano a la pelvis renal en una **conexión amplia en forma de embudo**
- Deja un **catéter (stent)** interno blando para mantenerla abierta mientras sana

Casi siempre se hace por vía **robótica o laparoscópica** con unas pocas incisiones pequeñas; a veces con una sola incisión abierta.

¿Es segura?

La pieloplastia es una operación bien establecida y muy eficaz, con un éxito duradero de más del 90%. Como toda cirugía, tiene algún riesgo — sangrado, infección o una fuga temporal de orina (se maneja con el catéter y un drenaje). Que el estrechamiento vuelva es poco común y suele poder tratarse de nuevo.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Riñón

El órgano que filtra la sangre y produce orina.

Uréter

El tubo que lleva la orina del riñón a la vejiga.

UPU

La unión ureteropélvica — donde el riñón se une al uréter; el punto obstruido.

Pelvis renal

La bolsa en forma de embudo donde se junta la orina antes de pasar al uréter.

Catéter ureteral

Un tubo interno blando (un “doble J”) que mantiene abierta la reparación mientras sana.

Vaso cruzado

Un vaso sanguíneo que puede presionar la unión y causar la obstrucción.

Hidronefrosis

Hinchazón del riñón por la orina que se acumula detrás de la obstrucción.

Robótica / laparoscópica

Cirugía por incisiones pequeñas, hecha con unos pocos cortes.

¿LE DOLERÁ? La cirugía se hace con anestesia general, así que no siente nada durante ella. Después, espere molestias en las incisiones pequeñas y a veces dolor en el hombro o el abdomen por el gas usado en la cirugía. El catéter interno puede causar algo de urgencia o una leve molestia en el costado al orinar. La mayoría se queda 1–2 noches; la cirugía suele durar 2–3 horas.

Cómo prepararse (antes de la cirugía)

- Se hace con **anestesia general** — siga todas las instrucciones (ayuno y qué medicinas suspender, incluidos los anticoagulantes).
- Un **análisis de orina** busca infección — una infección debe tratarse primero.
- Cuente con un **catéter interno unas 4–6 semanas**, y organice quién lo lleve a casa.

Avise a su equipo con anticipación si usted:

- Toma un **anticoagulante** o tiene una infección de orina actual
- Ha tenido cirugía previa del riñón o del abdomen

Qué sucede durante la cirugía

- 1 Usted está dormido con anestesia y se le dan antibióticos.
- 2 El cirujano hace unas incisiones pequeñas (o una incisión abierta) y expone la unión obstruida.
- 3 Se quita el segmento estrecho y se remodela la pelvis renal.
- 4 Se une el uréter sano a la pelvis en un embudo amplio sobre un catéter; puede dejarse un drenaje pequeño y se cierran las incisiones.

Después de la cirugía

- Suele irse a casa en **uno o dos días**.
- Un **catéter queda dentro unas 4–6 semanas**, luego se retira en una cistoscopia rápida en el consultorio.
- Los síntomas del catéter — urgencia, leve molestia en el costado al orinar u orina rosada — son **normales**.
- **Evite levantar peso y hacer esfuerzo** por unas semanas, y tome bastante líquido.

Llame a su equipo o busque atención si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- Dolor intenso o que empeora en el costado o el abdomen
- Sangrado abundante o coágulos en la orina
- No puede orinar, o náuseas o vómitos persistentes
- Más enrojecimiento, dolor o supuración en una incisión

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La pieloplastia quita una obstrucción del drenaje del riñón y reconstruye una conexión amplia — la reparación más duradera, hecha casi siempre por incisiones pequeñas.
2. Para prepararse: siga las instrucciones de ayuno y medicinas, trate antes cualquier infección, cuente con un catéter unas 4–6 semanas y organice quién lo lleve.
3. Espere que el catéter cause algo de urgencia o molestia en el costado hasta que se retire en el consultorio. Llame enseguida si tiene fiebre, dolor intenso, sangrado abundante o no puede orinar.